

 요약문**'이것만은 꼭 기억하세요'****[불규칙한 월경주기]**

- 불규칙한 월경은 호르몬 불균형, 스트레스, 다낭난소증후군(PCOS), 갑상선 문제, 체중 변화 등 다양한 원인으로 인해 발생할 수 있습니다.
- 초경 후 몇 년이나 폐경 전후에 주로 나타나지만, 20~30대 여성도 여러 이유로 불규칙한 월경을 경험할 수 있습니다.
- 진단은 병력 청취, 신체검사, 호르몬 검사, 초음파 검사 등을 통해 이루어집니다.
- 치료로는 경구피임약과 같은 약물요법이 일반적이나, 필요한 경우 수술이 요구되기도 합니다.

[월경전증후군]

- 월경전증후군은 호르몬과 신경전달물질 변화가 주요 원인입니다.
- 월경전증후군은 두통, 피로, 복통, 메스꺼움, 유방통, 식욕변화, 우울감, 불안감, 집중력 저하, 수면패턴 변화 등 다양한 증상을 나타낼 수 있습니다.
- 월경전증후군은 정해진 진단 검사 방법이 없으나, 병력 청취, 신체검사, 혈액 검사, 호르몬 검사 등이 진단에 도움이 됩니다.
- 생활습관 개선, 약물치료, 영양 보충이 월경전증후군의 증상 관리에 효과적이며, 증상이 심한 경우 산부인과 전문의와의 상담이 중요합니다.
- 눈 시림 현상이 나타날 수 있습니다.

요약문

개요

[불규칙한 월경주기]

대부분의 여성은 초경 후 2~3년이 지나면 일정한 월경주기를 형성하므로 다음 월경 시작일과 기간을 예측할 수 있습니다. 하지만 월경이 너무 자주 또는 드물게 일어나면 신체가 보내는 이상 신호일 수 있습니다.

불규칙한 월경은 특히 여성의 특정 시기에 흔하게 발생합니다. 예를 들어, 초경 직후 몇 년간이나 폐경이 가까운 시기에는 호르몬 균형이 불안정해져 주기가 불규칙하게 변화하고, 월경량이 변동될 수 있습니다. 그러나 20~30대 여성에서도 다양한 이유로 불규칙한 월경이 발생할 수 있습니다.

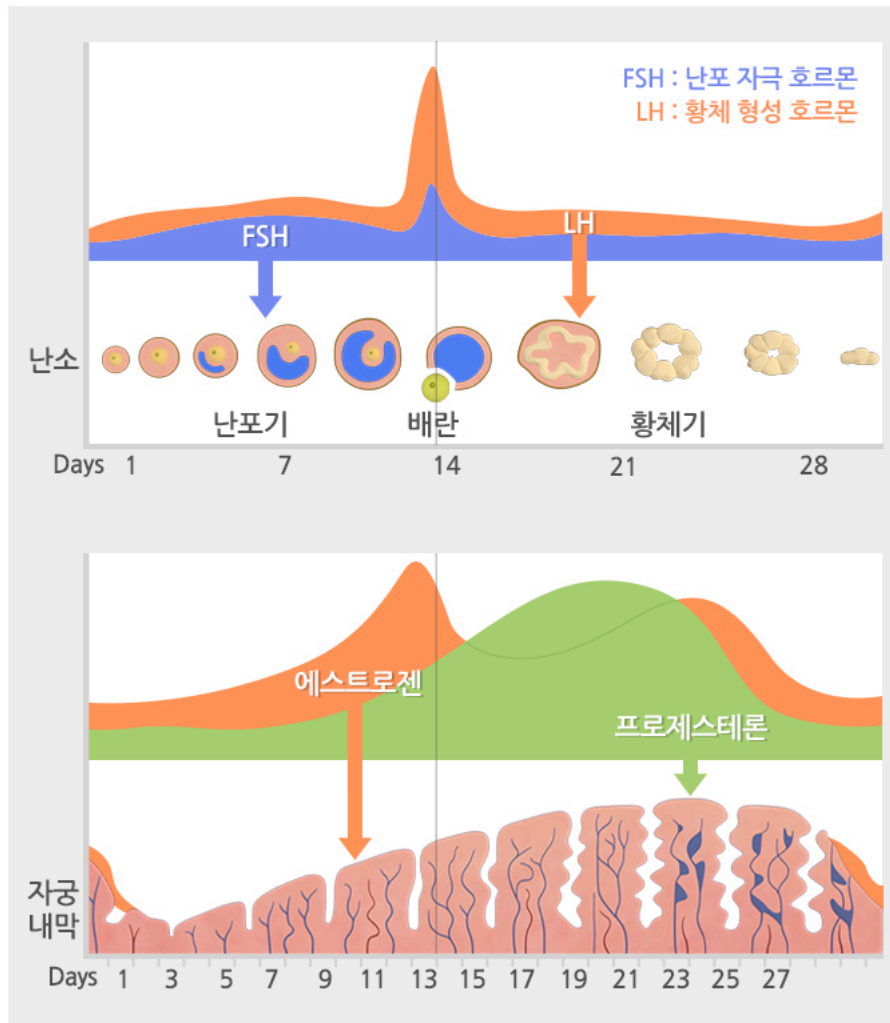
원인

불규칙한 월경주기는 여러 가지 원인에 의해 발생할 수 있습니다. 주요 원인은 다음과 같습니다.

1. 호르몬 불균형

월경주기를 조절하는 중요한 요소는 에스트로겐과 프로제스테론 같은 성호르몬입니다. 그러나 갑상선기능저하증, 다낭난소증후군과 같은 내분비계 질환이 있을 경우 이러한 호르몬의 균형이 깨져 월경이 불규칙하게 됩니다.

<그림 여성의 정상 월경주기와 호르몬 변화>



2. 스트레스

심리적 스트레스는 시상하부-뇌하수체-난소 축에 영향을 주어 호르몬 분비를 방해할 수 있습니다. 이로 인해 배란이 제대로 이루어지지 않거나 월경 주기가 변동될 수 있습니다. 또한 과도한 운동이나 급격한 체중 변화도 스트레스 요인으로 작용할 수 있습니다.

3. 다낭난소증후군(PCOS)

다낭난소증후군은 가임기 여성에게 안드로젠 과다로 인해 발생하며, 배란이 불규칙하거나 무배란이 나타나는 질환입니다. 그 결과 월경주기가 길어지거나 불규칙해질 수 있으며, 여드름이나 다모증 같은 증상이 동반되기도 합니다. 자세한 내용은 다낭난소증후군 관련 콘텐츠를 참조하시면 도움이 될 것입니다.
(국가건강정보포털 건강정보 보러가기: 다낭난소증후군)

4. 갑상선 문제

갑상선호르몬은 신체 대사를 조절하는데, 기능에 이상이 생기면 월경주기도 영향을 받습니다. 갑상선 기능이 저하되면 월경이 드물거나 과다하게 발생하고, 항진증이 있을 경우 월경이 아예 없거나 짧은 주기로 나타날 수 있습니다.

5. 체중 변화와 영양 상태

극단적인 다이어트나 영양 결핍도 월경 불규칙의 주요 원인입니다. 특히 체지방이 너무 낮으면 시상하부에서 배란 신호가 제대로 전달되지 않아 월경이 멈추거나 주기가 불규칙해질 수 있습니다.

이러한 원인들이 불규칙한 월경을 유발할 수 있으며, 주기가 지속적으로 변동될 경우 정확한 진단을 위해 전문의의 상담을 받는 것이 좋습니다.

진단과 평가

불규칙한 월경주기를 진단하고 평가하는 과정은 환자의 상태를 종합적으로 파악해 원인을 찾는 데 중점을 둡니다. 주요 절차는 다음과 같습니다.

1. 병력 청취

먼저 의사는 환자의 월경 주기, 출혈량, 마지막 월경일 등의 기본 정보를 확인하고 불규칙한 패턴이 있는지, 출혈의 변화가 있는지를 조사합니다. 또한, 스트레스, 체중 변화, 운동 습관, 약물 복용 여부, 임신 가능성 등 생활 요인도 청취하여 원인 파악에 도움을 줍니다.

2. 신체 검사

전반적인 건강 상태를 평가하기 위해 신체 검사가 시행됩니다. 갑상선 비대, 체중 변화 같은 내분비계 문제를 확인하고, 골반 검사 등을 통해 자궁이나 난소 같은 생식기관에 이상이 있는지 살펴봅니다.

3. 호르몬 검사

호르몬 불균형 여부를 확인하기 위해 에스트로겐, 프로게스테론, 난포자극호르몬, 황체형성호르몬, 갑상선호르몬, 안드로젠 수치를 측정하여 배란 여부나 다낭 난소증후군, 갑상선 기능 이상 등 내분비 질환을 감별합니다.

4. 초음파 검사

골반초음파는 자궁과 난소 상태를 시각적으로 평가할 수 있습니다. 난소 낭종, 자궁내막 두께, 자궁근종 여부 등을 확인하여 여성생식기의 구조적 문제가 월경 주기에 영향을 미치는지 파악합니다.

5. 기타 검사

필요 시 자궁내막 조직검사를 통해 자궁내막 상태를 확인하고, 갑상선 기능검사 등 내분비계 정밀 검사를 추가로 시행할 수 있습니다.

이와 같은 진단 과정을 통해 불규칙한 월경의 원인을 명확히 하고, 적절한 치료 계획을 세웁니다.

치료

불규칙한 월경의 치료는 증상을 유발하는 원인, 여성의 나이, 임신 계획 여부 등에 따라 달라집니다. 대부분 약물 치료를 통해 월경 주기가 정상화되거나 증상이 완화될 수 있으며, 약물 치료에 어려움이 있거나 통증이 지속적으로 동반되는 경우 수술 치료가 고려될 수 있습니다.

1. 약물 치료: 경구피임약

경구피임약은 불규칙한 월경을 조절하는 데 가장 일반적으로 사용되는 방법입니다. 매일 일정한 양의 호르몬을 복용하여, 체내 호르몬 균형을 유지함으로써 월경 주기를 안정시킵니다.

- **월경 주기 조절:** 호르몬을 보충하여 주기를 일정하게 만들어, 규칙적인 월경이 가능합니다.
- **출혈량과 월경통 감소:** 과다출혈이나 심한 월경통을 완화하는 효과가 있습니다.
- **배란 조절:** 배란을 안정적으로 조절해 불규칙한 월경주기를 개선할 수 있습니다.

장점: 치료가 간편하고 주기를 규칙적으로 만들어주며, 월경통을 줄이는 효과가 있습니다.

주의사항: 초기에는 두통이나 메스꺼움과 같은 부작용이 있을 수 있지만 대부분 시간이 지나면서 사라집니다. 다만 꾸준한 복용이 필수적이며, 매우 드물게 혈전증과 같은 심각한 부작용이 발생할 수 있으나 청소년기에는 드뭅니다.

2. 수술 치료

수술은 **약물로 증상을 관리하기 어려운 경우나** 자궁 또는 난소에 구조적 문제가 있을 때 고려됩니다. 청소년기에는 드문 편이며, 다음과 같은 경우에 적용될 수 있습니다.

- **자궁이나 난소의 이상:** 자궁이나 난소에 낭종이나 혹이 생겨 월경이 불규칙한 경우, 이를 제거하는 수술을 시행할 수 있습니다.
- **자궁근종:** 자궁근종으로 인해 불규칙한 월경과 과다출혈이 발생할 때, 근종을 제거하는 수술이 도움이 될 수 있습니다.

주의사항: 수술은 **약물로 해결되지 않는 경우에만** 선택하는 방법입니다. 청소년에게는 매우 드물며, 대부분 약물 치료로 충분히 관리가 가능합니다.

<표 불규칙한 월경주기 체크리스트>

월경이 정상적인 패턴을 벗어나 이상하다고 느껴지는 경우에는 전문의의 상담을 받아보는 것이 좋습니다.
다음 항목 중 해당되는 사항이 있다면 지금 산부인과 전문의와 상담해 보세요!

- ☐ 규칙적이던 월경이 최근 불규칙해졌다
- ☐ 90일 이상 월경을 하지 않았다
- ☐ 월경주기가 21일보다 짧거나 35일보다 길다
- ☐ 월경이 일주일 이상 지속된다
- ☐ 월경 기간이 아닌 때에 출혈이 있다
- ☐ 평소에 월경량이 너무 많거나 또는 최근에 갑자기 많아졌다

[월경전증후군이란?]

월경 때만 다가오면 통통 붓는 몸과 우울하고 예민해지는 자신의 모습에 스스로 당황스러웠던 기억이 있나요?

월경전증후군(Premenstrual Syndrome, PMS)은 월경이 시작되기 전 1~2주 동안 신체적, 감정적 변화가 나타나는 증상을 일컫습니다. 많은 여성이 겪는 이 증상은 개인에 따라 다양하게 나타날 수 있습니다.

1. 주요증상

- **신체 증상:** 두통, 피로감, 복통, 메스꺼움, 유방통, 식욕변화(특히 식탐), 부종, 체중 증가, 관절통, 근육통 등이 있을 수 있습니다.
- **정신 증상:** 우울감, 분노, 불안감, 예민함, 집중력 저하, 성욕 변화, 수면 변화(불면증 또는 과다수면) 등이 포함됩니다.

2. 월경전증후군 진단 기준

미국산부인과학회에 따르면 월경전증후군 진단을 위해서는 신체적 또는 정신적 증상이 생리 시작 5일 전부터 시작해 생리 시작 후 4일 이내 사라지고, 다음 생리 주기까지 재발하지 않는 패턴이 두 주기 이상 확인되어야 합니다. 또한 약물, 호르몬, 알코올이나 약물 남용 등으로 인한 것이 아니며, 사회적, 경제적으로 일상생활에 지장을 줄 정도로 증상이 심각해야 합니다. 정확한 진단과 적절한 치료를 위해 전문의와의 상담이 권장됩니다.

원인

월경전증후군(PMS)의 정확한 원인은 아직 완전히 밝혀지지 않았지만, 주요 원인으로는 호르몬 변화, 신경전달물질의 변화, 유전적 요인이 제시되고 있습니다.

1. 호르몬 변화

월경주기 동안 성호르몬인 에스트로겐과 프로게스테론의 급격한 변화가 PMS 증상을 유발할 수 있습니다. 배란 후 프로게스테론 수치가 증가했다가 월경 직전 급격히 감소하면서 신체적, 감정적 증상들이 나타날 수 있습니다.

2. 세로토닌 변화

세로토닌은 기분, 감정, 수면 조절에 중요한 신경전달물질로, 호르몬 변화가 세로토닌 수치에 영향을 미쳐 PMS 증상인 기분 변화, 피로감, 불면증을 유발할 수 있습니다.

3. 유전적 요인

가족 중 월경전증후군을 겪는 사람이 있을 경우, 증상이 나타날 가능성이 높습니다. 이는 호르몬과 신경전달물질의 민감도가 유전적으로 영향을 받을 수 있기 때문입니다.

검사 방법

월경전증후군의 진단을 위한 확립된 검사법은 없지만, 다음과 같은 방법이 일반적으로 시행될 수 있습니다.

- 병력 청취
- 신체 검사
- 혈액 및 호르몬 검사

정확한 진단을 위해 증상 일지나 설문지를 통한 기록도 중요한 역할을 합니다. 월경주기 동안 증상 발생 시기, 강도, 종류를 기록해 두면 주기적으로 반복되는 증상 패턴을 파악하는 데 도움이 됩니다.

치료

월경전증후군의 치료는 증상을 완화하고 일상생활에 미치는 영향을 줄이는 데 초점을 맞추며, 주요 방법은 다음과 같습니다.

1. 생활습관 변화

- **식습관 개선:** 카페인, 소금, 설탕의 섭취를 줄이고, 충분한 물과 영양소가 풍부한 음식을 섭취하면 증상 완화에 도움이 됩니다.
- **운동:** 규칙적인 유산소 운동은 기분을 개선하고 신체적 증상을 완화할 수 있습니다.
- **스트레스 관리:** 명상, 요가, 충분한 수면은 스트레스를 줄이고 감정적 증상을 완화하는 데 효과적입니다.

2. 약물치료

- **진통제:** 이부프로펜 같은 비스테로이드소염제(NSAIDs)는 복통, 두통 등 신체 증상 완화에 유용합니다.
- **경구피임약:** 호르몬 변화를 안정시켜 월경전증후군 증상을 줄여줍니다.
- **항우울제:** 심한 감정적 증상이 있을 때, 세로토닌 수치를 조절하는 항우울제(선택 세로토닌재흡수억제제, Selective Serotonin Reuptake Inhibitors, SSRIs)를 처방 받을 수 있으며, 이는 기분 조절에 도움이 됩니다.

3. 영양 보충제

- **칼슘, 마그네슘, 비타민 B6** 등의 영양소가 증상 완화에 효과적일 수 있습니다.

<표 월경전증후군 체크리스트>

지난 세 번의 월경 주기에서 아래와 같은 신체, 정신 증상 중 1개 이상이 월경 전 5일 동안 발생한 경우에는 전문의와 상담이 필요할 수 있습니다.

신체 증상	정신 증상
☐ 유방에 통증이 있다	☐ 우울해진다
☐ 배에 가스가 차거나 불편한 느낌이 있다	☐ 화가 난다
☐ 두통이 있다	☐ 신경이 날카로워진다
☐ 손이나 발이 붓는다	☐ 불안감이 든다
	☐ 그냥 혼란스럽다
	☐ 혼자 있고 싶어진다

자주하는 질문

Q. 규칙적으로 월경하다가 갑자기 몇 달 동안 안 하는 경우도 있나요?

A.

네. 규칙적인 월경을 하다가 갑자기 몇 달 동안 월경을 하지 않는 경우가 있을 수 있습니다. 이러한 현상은 여러 가지 원인에 의해 발생할 수 있습니다. 가장 흔한 원인으로는 심한 스트레스, 체중 변화, 과도한 운동 등이 있습니다. 또한, 갑상선 기능 이상, 다낭난소증후군과 같은 내분비 문제도 갑작스러운 월경 중단을 유발할 수 있습니다. 가임기 여성이라면 임신 여부도 반드시 확인해야 하며, 이런 변화가 지속된다면 전문의와의 상담이 필요합니다.

Q. 한 달은 월경량이 많았다가 다음 달에는 아주 적게 나오기도 하는데 왜 그럴까요?

A.

월경량의 변화는 여러 가지 원인에 의해 발생할 수 있으며, 그 중 가장 흔한 원인은 호르몬 불균형입니다. 월경 주기를 조절하는 에스트로겐과 프로게스테론의 균형이 깨지면 월경량이 달라질 수 있습니다. 예를 들어, 배란이 제대로 이루어지지 않거나, 심한 스트레스, 체중 변화, 과도한 운동 등이 호르몬에 영향을 미쳐 월경량의 변화를 일으킬 수 있습니다.

또한, 자궁내막의 상태가 불규칙하거나 자궁근종, 자궁폴립과 같은 자궁의 이상도 비정상적인 출혈을 유발할 수 있습니다. 이런 출혈은 월경으로 착각될 수 있습니다. 따라서 반복적으로 이런 증상이 발생할 경우 부인과 진료를 받는 것이 필요합니다.

Q. 월경통이 심해서 진통제를 자주 먹는데, 어른이 되어서도 계속 이럴까요?

A.

월경통은 보통 일차 월경통과 이차 월경통으로 나뉩니다. 일차 월경통은 호르몬 변화에 의해 발생하며, 종종 청소년기에 시작되어 나이가 들면서 자연스럽게 완화되는 경우가 많습니다. 그러나 이차 월경통은 자궁내막증, 자궁근종 등 특정 질환이 원인일 수 있어 성인이 되어서도 지속되거나 심해질 수 있습니다.

진통제를 자주 복용해야 할 정도로 통증이 심하다면, 일단 의학적인 평가를 받아보는 것이 중요합니다. 반복적인 통증이 지속될 경우 원인 질환을 확인하고 치료를 받는 것이 필요하며, 전문의와의 상담을 통해 적절한 관리 방법을 찾는 것이 좋습니다.

Q. 월경할 때 쓰러지기도 하는데, 중요한 시험을 앞두고 있어 걱정이 돼요. 어떻게 해야 할까요?

A.

월경 중 쓰러지거나 심한 어지럼증을 겪는 경우는 빈혈, 저혈압, 심한 월경통 등이 원인일 수 있으며, 몸이 보내는 경고 신호일 수 있습니다. 특히 철결핍성 빈혈이 있다면 출혈이 많을 때 어지럼증과 피로가 더 심해질 수 있어 미리 준비하는 것이 중요합니다. 큰 시험을 앞두고 있다면 철분 보충제를 복용하거나, 진통제를 미리 준비해 통증을 관리하세요. 충분한 수면과 영양 섭취도 중요합니다. 증상이 계속 심하거나 쓰러지는 경우, 다른 질환 가능성도 있으므로 전문의와 상의해 관리 방법을 철저히 찾아보는 것이 좋습니다.

참고문헌

1. 군자출판사. (2022). 부인과내분비학 (2판).

2. American College of Obstetricians and Gynecologists. (2015). Premenstrual syndrome. ACOG Practice Bulletin, Clinical Management Guidelines for Obstetrician–Gynecologists, Number 15.

